



**ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я**

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

НАКАЗ

від 28.11. 2023

Львів

№ 840 / 381 Б

***Про роль та функції ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»
та закладів охорони здоров'я при відстеженні
контактних осіб з хворими на туберкульоз***

З метою проведення епідеміологічного нагляду за контактними особами з випадком туберкульозу, на виконання пп.1, 2 статті 9 Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз», ст. 9, 13, 14 Закону України «Про систему громадського здоров'я», наказів МОЗ України від 19.01.2023 № 102 «Про затвердження стандартів медичної допомоги «Туберкульоз», від 09.03.2021 № 406 «Про затвердження Порядку епідеміологічного нагляду за туберкульозом та Зміни до критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації», від 16.02.2022 № 302 «Про затвердження Порядку організації виявлення туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції», з метою вдосконалення епідеміологічного нагляду за контактними особами з випадками туберкульозу в Львівській області, -

НАКАЗУЄМО:

1. Керівникам закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу населенню (незалежно від форми власності та організаційно-правової форми), фізичним особам-підприємцям забезпечити:

1.1. Обстеження та динамічне спостереження за контактними з хворими на туберкульоз особами згідно Алгоритму обстеження контактних осіб, затвердженого наказом МОЗ України від 09.03.2021 № 406 «Порядок епідеміологічного нагляду за туберкульозом».

1.2. Проведення збору анамнезу життя у індексного пацієнта (фактичне місце проживання, роботи/навчання/ тривалого перебування, професія), анамнезу хвороби (скарги, хронологія появи скарг), збір детальної інформації щодо контактних осіб (персональні дані, тривалість контакту та тип контакту, номер телефону контактних осіб – з внесенням даних про контактних до ф.025/о «Медична карта амбулаторного хворого».

1.3. При виявленні у контактних осіб туберкульозної інфекції – заповнення та відправлення Екстреного повідомлення (форма № 058/о) до відокремленого

підрозділу ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» за місцем фактичного проживання пацієнтів.

1.4. Передачу інформації щодо контактних осіб (результатів обстеження, динамічного спостереження) у відокремлені підрозділи ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ», а також лікарям-фтизіатрам територіальних протитуберкульозних закладів КНП ЛОР «Львівський обласний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр».

1.5. Навчання індексних випадків туберкульозу та їх контактних осіб правилам інфекційного контролю відповідно до наказу МОЗ України від 01.02.2019 № 287 «Про затвердження Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров'я, що надають допомогу хворим на туберкульоз».

1.6. Виконання наступної послідовності дій: При виявленні у контактної особи активного ТБ скеровувати на консультацію до лікаря-фтизіатра з метою реєстрації випадку ТБ та призначення протитуберкульозного лікування відповідно до результатів ТМЧ, у разі відсутності даних за активний ТБ – призначення профілактичного лікування ТБ, особливу увагу слід приділяючи дітям до п'яти років та людям, що живуть з ВІЛ.

1.7. Заповнення форми первинної облікової документації № 030-4/о «Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз та особою із груп ризику», затвердженої наказом МОЗ України від 29.05.2013 № 435 на кожну контактну особу лікарем, який здійснює обстеження та подальше спостереження,.

2. В.о. генерального директора КНП ЛОР «Львівський обласний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» Л. Раку забезпечити:

2.1. Збір анамнезу життя індексного пацієнта (фактичне місце проживання, роботи/навчання/ тривалого перебування, професію), анамнезу хвороби (скарги, хронологія появи скарг).

2.2. Збір детальної інформації щодо контактних осіб (персональні дані, тривалість контакту та тип контакту, контактний номер телефону контактної особи, ПІБ сімейного лікаря, з яким у контактної особи укладено декларацію, або назву закладу охорони здоров'я, в якому укладено декларацію) із занесенням цих даних у форму первинної облікової документації №081/о «Амбулаторна карта хворого на туберкульоз №____», затверджену наказом МОЗ України 28.07.2014 № 527.

2.3. Проведення роз'яснювальної роботи з індексним пацієнтом щодо необхідності обстеження контактних осіб з наданням рекомендації щодо їх звернення до закладу охорони здоров'я .

2.4. Заповнення та скерування екстреного повідомлення (форма № 058/о) до відокремленого структурного підрозділу ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» за місцем фактичного проживання індексного пацієнта.

2.5. При отриманні форму № 089/о про встановлення лікарем-патологоанатомом або судово-медичним експертом діагнозу туберкульоз у особи, яка не перебувала під медичним наглядом у протитуберкульозних закладах, скеровувати інформацію про таку особу до ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ».

3. Завідувачам відокремлених структурних підрозділів ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ», завідувачу відділу епіднагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»:

3.1. Впродовж трьох робочих діб з моменту отримання Екстреного повідомлення №058/о розпочати епідеміологічне розслідування з визначенням меж осередку захворювання, встановленням кола контактних осіб та контролю за їх своєчасним клінічним та лабораторними обстеженнями.

3.2. У ході епідеміологічного розслідування заповнювати форму обліково-статистичної документації №357/о «Карта епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання», затверджену наказом МОЗ України від 11.07.2000 №160, завірену копію якої передавати лікарю-фтизіатру та до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу населенню (незалежно від форми власності та організаційно-правової форми) або фізичним особам-підприємцям за місцем укладення декларації хворого на туберкульоз.

3.3. Здійснювати виїзд в осередок туберкульозної інфекції та проведення первинного епідеміологічного обстеження осередку. Першочергово проводити обстеження контактних з індексним випадком, якщо першим в осередку виявлений випадок ТБ легень з бактеріовиділенням, підтвердженим за результатом мікроскопічного дослідження мокротиння; випадок лікарсько-стійкого ТБ; випадок коінфекції ТБ/ВІЛ; ТБ у дитини до п'яти років (для швидкого встановлення джерела інфекції) спільно з сімейним лікарем та лікарем фтизіатром за можливості.

3.4. Проводити збір епідеміологічного анамнезу, збір даних щодо контактних осіб (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце фактичного проживання, контактний номер телефону, тривалість контакту та тип контакту, ПІБ сімейного лікаря, з яким у контактної особи укладено Декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або назву закладу де укладено декларацію).

3.5. Проводити ідентифікацію та пріоритизацію контактних осіб за ступенем ризику виникнення ТБ, пошук джерела інфекції, так як індексний випадок не завжди є джерелом інфекції.

3.6. Розробляти клінічний маршрут контактних осіб та повідомляти останніх.

3.7. Проводити динамічне спостереження за вогнищем, роз'яснювальну роботу з питань ТБ.

3.8. Здійснювати епідеміологічний аналіз захворюваності на ТБ на територіях.

3.9. Здійснювати обмін персоніфікованими даними про наявних контактних осіб та заходи, що проведені в осередку ТБ між лікарями-епідеміологами (помічниками-епідеміолога), лікарями-фтизіатрами та фахівцями закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу населенню (незалежно від форми власності та організаційно-правової форми), фізичним особам-підприємцям з ким укладені декларації.

3.10. За результатами епідемічної ситуації з захворюваності на туберкульоз та проведеного аналізу надавати пропозиції керівникам закладів охорони здоров'я на підпорядкованих територія щодо попередження поширення туберкульозу серед населення (захворюваність, смертність, хворобливість, інфікованість).

3.11. З метою проведення оцінки епіднагляду за контактними особами, один раз у рік проводити розрахунок середньої кількості контактних осіб на один індекс-випадок ТБ, який повинен бути не нижчим, ніж середній розмір домогосподарства.

4. Завідувачам відокремлених структурних підрозділів ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ», в.о. генерального директора КНП ЛОР «Львівський обласний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» Л.Раку, керівникам закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу населенню (незалежно від форми власності та організаційно-правової форми), фізичним особам-підприємцям забезпечувати:

4.1. Спільний виїзд в осередок туберкульозної інфекції у закладах освіти і дитячих закладах оздоровлення і відпочинку та за місцем праці працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (згідно переліку Постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 №559) для виявлення та обстеження контактних осіб.

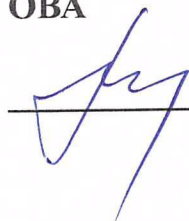
4.2. Щорічне проведення заходів щодо вивчення нормативної документації з питань діагностики, епідеміології та профілактики ТБ.

4.3. Інформаційно-просвітницьку роботу з населенням щодо питань профілактики ТБ і формування здорового способу життя із залученням засобів масової інформації та інтернет-ресурсів.

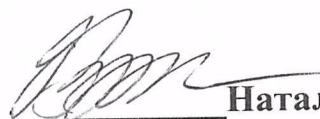
4.5. Коректний обмін необхідною інформацією щодо хворого на туберкульоз між взаємодіючими закладами охорони здоров'я та ДУ «Львівський ОЦКПХ» задля сприяння ефективності роботи з попередження захворювання серед контактних.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

Т.в.о. директора департаменту
охорони здоров'я Львівської
ОВА

 **Наталія ЛІТВІНСЬКА**

Генеральний директор
ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»

 **Наталія ІВАНЧЕНКО**